

ΟΞΕΙΑ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ

Γενικά: Αφορά συνηθέστερα σε νεαρές γυναίκες (προεμμηνοπαυσιακές) μη εγκύους, χωρίς βλάβες ή επιπλοκές από το ουροποιητικό σύστημα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Συνήθως, είναι βακτηριακής αιτιολογίας και σπανιότατα ιογενούς. Συνήθη παθογόνα είναι: από τα Gram (-) μικρόβια: *E.coli*, *Proteus sp.*, *Klebsiella pneumoniae*, ενώ από τα Gram (+) μικρόβια: *Staphylococcus saprophyticus*, στελέχη *Enterococci* και στελέχη *Lactobacillus*. Ο κίνδυνος μη επιπλεγμένης κυστίτιδας σχετίζεται ισχυρά με πρόσφατη σεξουαλική επαφή, πρόσφατη χρήση κολπικού διαφράγματος, προϋπάρχουσα ασυμπτωματική βακτηριουρία και ιστορικό υποτροπιάζουσών ουρολοιμώξεων (3 επεισόδια/έτος ή 2 επεισόδια/εξάμηνο).

Κλινική εικόνα: Έντονα τοπικά ερεθιστικά φαινόμενα (επιτακτική επώδυνη ούρηση, μικρο- ή μακροσκοπική αιματουρία, στραγγουρία, υπερηβικό άλγος). Απουσία πυρετικής κίνησης.

Εργαστηριακός έλεγχος: Γενική ούρων (θετική λευκοκυτταρική εστέρηση, θετικά νιτρώδη). Καλλιέργεια ούρων. Γενική αίματος (σπάνια ήπια λευκοκυττάρωση), ενίοτε αυξημένη CRP.

Διαφορική διάγνωση: Αιδιοκολπίτιδα (*Candida*, *Trichomonas*, *Gardnerella*), ουρηθρικό σύνδρομο, ουρηθρίτιδα, φυματίωση του ουροποιητικού, προστατίτιδα, διάμεση κυστίτιδα, μετακινική ή μετά χημειοθεραπεία κυστίτιδα, καρκίνος κύστης, ψυχοσωματικά σύνδρομα.

Θεραπευτική παρέμβαση

Εμπειρική θεραπεία (δεν απαιτείται καλλιέργεια ούρων): Οι συστάσεις βασίζονται στην επιδημιολογία της αντοχής του συχνότερου ουροπαθογόνου (*E. coli*) στη χώρα μας, με βάση τα τελευταία δεδομένα. Αντιβιοτικά με ποσοστό αντοχής > 20% δεν συνιστώνται ως εμπειρική αγωγή. Προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο δεν επιτρέπει τη χορήγηση, εμπειρικά, αντιμικροβιακού της ίδιας ομάδας (εκτός εάν υπάρχει αντιβιογράμμο).

1. Πρώτης επιλογής θεραπευτική παρέμβαση (σε παρένθεση τα ποσοστά αντοχής), είναι:

- Φωσφομυκίνη (1,6%): such. *Fosfocin* 3 gr, άπαξ (po), ή
- Κεφουροξίμη (1,7%): tab. *Zinadol/Nelabocin* 500 mg, 1x2 (po), για 7 ημέρες, ή
- Πιβμεκιλινάμη (3,4%): tab. *Selexid* 200 mg, 2x2 (po), για 5-7 ημέρες, ή
- Αμοξυκιλλίνη/Κλαβουλανικό (5,2%): tab. *Augmentin* 1 gr, 1x2 (po), για 7 ημέρες, ή
- Νιτροφουραντοΐνη (10,7%): tab. *Furolin* 100 mg, 1x3 (po), για 5-7 ημέρες, ή
- Κοτριμοξαζόλη (19,2%): tab. *Septtrin/Bactrimel* 960 mg, 1x2 (po), για 3-5 ημέρες.

2. Εναλλακτικά (ή επί θεραπευτικού αδιεξόδου) μπορεί να χορηγηθεί μια **Φθοριοκινολόνη**:

- Νορφλοξασίνη: tab. *Norocin* 400 mg, 1x2 (po), για 3 ημέρες, ή
- Σιπροφλοξασίνη: tab. *Ciproxin/Ladinin* 500 mg, 1x2 (po), για 3 ημέρες, ή
- Λεβοφλοξασίνη: tab. *Tavanic/Envoxil* 500 mg, 1x1 (po), για 3 ημέρες.

Οι Κινολόνες δεν συνιστώνται ως αρχική εμπειρική θεραπεία. Αντιθέτως, πρέπει να διαφυλάσσονται για επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις, από πολυανθεκτικά εντεροβακτηριακά, και στις περιπτώσεις αυτές να χορηγούνται για 7-14 ημέρες, αναλόγως των συνθηκών.

Υποχώρηση των συμπτωμάτων σε 24-48 ώρες, υποδηλώνει την ορθότητα της θεραπευτικής αγωγής. Επαναλαμβανόμενη λοίμωξη θεραπεύεται πάντοτε με βάση νέο αντιβιογράμμο.

Χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη των υποτροπιάζόντων επεισοδίων, είναι:

- ♦ Λήψη άφθονων υγρών, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και γενικότερα.
- ♦ Αποφυγή τροφών, όπως καφές, τσάι, σοκολάτα, αλκοόλ, αναψυκτικά, πικάντικα, κ.λπ.
- ♦ Αποφυγή χρήσης αντισυλληπτικών διαφραγμάτων.
- ♦ Απομάκρυνση των εκκρίσεων, όπως επίσης και ούρηση μετά από κάθε σεξουαλική επαφή.
- ♦ Κατανάλωση χυμών από μούρα (π.χ. *cranberries*, *blueberries*) ή σκευασμάτων με εκχύλισμα *Cranberry* (*Cranfix*, *Manocelan*, 1x2/ημέρα) ή μαζί με προβιοτικά (*Democran*, 1x1/24ωρο). Η κατανάλωση χυμών μούρων φαίνεται ότι παρεμποδίζει την προσκόλληση του *E. coli* στο ουροεπιθήλιο, μέσω αδρανοποίησης του κροσσώτου (μουκοπολυσακχαριδίου) της επιφάνειας.

